

림프종 진단 첫 30일

아형 · 병기 · 항암치료 흐름 이해

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 11

MINI 무료 배포판 · Instagram 구독자용 · 2026년 10월 개정 2판

림프종은 이름이 같아도 아형에 따라 ‘지켜보기’부터 ‘즉시 치료’까지
다릅니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — B-Cell Lymphomas / Hodgkin Lymphoma / T-Cell Lymphomas, Version 4.2026(B세포 림프종 기준) 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 MINI판에 대하여

이 MINI판은 진단 후 첫 30일 동안 **안전하게 판단하는 데 꼭 필요한 내용만** 담았습니다. 응급 신호, 진단 직후 할 일, 병리·병기의 핵심, 치료 흐름, 진료실 질문, 한 장 요약은 완전판과 같습니다. 30일 일자별 실행 로드맵, 치료별 준비·회복 가이드, 한국 제도·보험 서류 안내, 마음 돌보기와 보호자 가이드, 워크북은 완전판에 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 아형이 치료를 정합니다

30초 요약

- 림프종은 **호지킨 림프종**과 **비호지킨 림프종**으로 나뉘고, 비호지킨은 다시 수십 가지 아형이 있습니다.
- 크게 **빨리 자라는(공격성) 림프종**은 곧바로 치료하고, **천천히 자라는(저등급) 림프종**은 증상이 없으면 **관찰**하기도 합니다.
- 진단에는 **림프절 절제 또는 굵은 바늘(중심부) 조직검사**가 필요합니다. 가는 바늘 세포검사만으로는 아형을 정하기 어렵습니다. 조직검사 전에는 **스테로이드를 임의로 먹지 마세요** — 림프종 세포가 줄어 진단이 어려워질 수 있습니다.
- 리툰시맙 같은 항CD20 치료 전 B형간염 검사**는 한국 환자에게 특히 중요한 안전 단계입니다.

아형(예)	속도	흔한 첫 치료
미만성 거대B세포 림프종(DLBCL)	빠름	항CD20 항체 + 항암(일부 고위험은 항체-약물접합체(ADC) 병용 요법)
여포성 림프종	대개 느림	저부담이면 관찰, 증상·부담 크면 치료, 국소면 방사선
변연부 림프종(MALT 등)	느림	위 MALT는 헬리코박터 제균, 실패 시 방사선
외투세포 림프종	다양	아형 특성에 맞춘 요법
소림프구성 림프종	느림	만성림프구백혈병과 같은 방식으로 관리

아형(예)	속도	흔한 첫 치료
호지킨 림프종	빠른 편, 완치율 높음	병기별 항암 ± 방사선, 진행기는 면역치료 병용 항암 범주
T세포·NK/T세포 림프종	다양	아형별 요법, 임상시험 고려

분류 기준(WHO 5판·ICC)에 따라 보고서 용어가 조금 다를 수 있습니다.
DLBCL에서는 **MYC·BCL2 재배열** 여부가 치료 상의에 특히 중요합니다.

오늘 물어볼 질문

1. 제 림프종의 정확한 아형은 무엇인가요?
2. 빨리 자라는 쪽인가요, 천천히 자라는 쪽인가요?
3. 바로 치료를 시작하나요, 관찰하나요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자

- **항암 중 38°C 이상 발열·오한** → 해열제보다 먼저 연락(호중구 감소 시 감염은 빠르게 진행)
- **눈·피부가 노래짐, 소변이 콜라색, 심한 피로**(B형간염 재활성화 가능성)
- **얼굴·목이 붓고 숨이 참**(종격동 덩이 압박)
- **등 통증 + 다리 힘 빠짐·대소변 장애**(척수 압박)
- **첫 치료 직후 소변량 감소·심한 피로·근육 경련·두근거림**(종양용해증후군)
- **CAR-T·이중특이항체 치료 후 발열, 어지럼·저혈압, 말·글씨·행동 변화, 경련**(사이토카인방출증후군·신경독성) → 즉시 치료기관 연락
- **면역치료 중 숨참·기침, 심한 설사**
- **스스로를 해치고 싶은 생각** → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 호중구 감소 중 발열은 응급입니다.
2. B형간염은 과거에 앓고 나온 사람도 항CD20 치료 중 다시 활동할 수 있습니다.
3. 큰 종격동 덩이는 기도·혈관을 누를 수 있습니다.
4. 척추·신경 압박은 시간이 중요합니다.
5. 종양용해증후군은 빨리 자라는 림프종의 첫 치료 때 생길 수 있어 수액·약으로 예방합니다.
6. 세포치료 후 부작용은 모두에게 생기지 않지만, 생기면 빠른 치료가 효과적입니다.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 조직검사 결과(아형) 확인 ② 혈액종양내과 예약 ③ 아이 계획이 있다면 **첫 항암 전** 가임력 상담 요청.

오늘 할 일 (3개)

- □ 병리보고서 — 아형, 면역염색, (DLBCL) MYC·BCL2 결과
- □ 혈액종양내과(림프종 진료) 예약
- □ 가임력: 남성은 **정자 동결**(첫 항암 전), 여성은 난자·배아 동결(약 2주 안팎). 공격성 림프종은 치료를 늦출 수 있는지 혈액내과와 함께 정합니다. 치료 중과 치료 후 일정 기간은 피임이 필요합니다(기간은 요법별로 확인).

이번 주 할 일

- □ **PET/CT**(병기·반응평가 기준), 혈액검사(LDH 젖산탈수소효소 — 종양 활동량을 짐작하는 수치)
- □ 필요 시 골수검사, 심장 초음파(안트라사이클린 계열 전)
- □ **B형간염 검사**(표면항원 HBsAg, 핵심항체 anti-HBc) → 양성이면 **예방 항바이러스제**
- □ C형간염·HIV 검사
- □ 산정특례 신청(확진일로부터 30일 이내; 관찰만 하는 경우 적용 시점 원무과 확인)

B형간염 상태별 안내

검사 결과	의미	흔한 조치
HBsAg 양성	현재 보유자	항암 전 또는 동시에 예방 항바이러스제 시작

검사 결과	의미	흔한 조치
HBsAg 음성 / anti-HBc 양성	과거 감염	항CD20 치료 때는 예방 항바이러스제가 흔히 권고됨, 또는 HBV DNA 정기 검사 (병원 방침·급여 확인)
모두 음성	감염 이력 없음	일반적 관리

> 예방 항바이러스제는 **치료가 끝난
뒤에도 일정 기간** 계속합니다.
임의로 끊지 마세요.

오늘 물어볼 질문

1. 병기 검사(PET/CT·골수검사)는 언제 하나요?
2. B형간염 검사 결과와 예방약 계획은요?
3. 가임력 보존을 할 시간이 있나요?

4장. 병기와 반응평가

30초 요약: 림프종은 PET/CT 기반 병기(Lugano)를 씁니다. 숫자보다
"림프절 몇 군데, 횡격막 위아래, 림프절 밖 장기 침범"이 중요합니다. 치료 중
·후에는 Deauville 점수(1~5)로 반응을 봅니다.

병기	쉬운 뜻
I	림프절 한 부위
II	횡격막 한쪽의 두 부위 이상
III	횡격막 위아래 양쪽

병기	쉬운 뜻
IV	림프절 밖 장기(골수·간·폐 등)에 넓게
B증상	원인 모를 38°C 이상 발열, 밤에 흠뻑 젖는 땀, 6개월에 10% 이상 체중 감소
큰 덩이(bulky)	덩이가 매우 큼 — 치료 계획에 영향
위험도 점수(IPI·FLIPI 등)	치료 강도를 정하는 참고값 — 내 남은 수명을 뜻하지 않음

국내 결과지·안내문에는 **Ann Arbor(앤 아버) 병기**로 적히기도 합니다.
Lugano는 Ann Arbor를 고친 체계라 I~IV기의 뜻은 거의 같고, 숫자 뒤의 A·B는 B증상이 없음·있음을 뜻합니다.

 **완전판에서 이어집니다** — PET 판독지 읽기, 병리 체크표

내 기록: 아형 _ · **병기** _ · B증상 ☐ · 큰 덩이 ☐ · LDH _ · **골수** _ · HBsAg _ /
anti-HBc _ · 예방약 _____

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

5장. 공격성 B세포 림프종(DLBCL 등)

30초 요약: 항CD20 항체 + 항암 병용(대표 예: R-CHOP), 일부 고위험군은 **ADC를 포함한 병용 요법** 범주(국내 허가·급여 확인 필요). 대개 3주 간격 6주기이며, 범위가 좁고 위험인자가 적으면 반응에 따라 4주기로 줄이기도 합니다. 중간 PET으로 반응을 확인합니다. 나이·심장·신장 기능에 따라 용량을 줄인 요법을 쓰며, **나이만으로 치료가 불가능하다고 판단하지 않습니다.**

- 뇌 재발 위험이 높은 일부는 뇌 예방 치료를 상의합니다.
- 1차 치료 뒤 **일찍 재발하거나 듣지 않으면 CAR-T 세포치료, 이중특이항체**(단독 또는 항암과 병용) 등 범주가 있습니다(순서·국내 허가·급여·시행기관 확인 필요).
- 늦게 재발했고 체력이 좋다면(국내 자료 기준 대개 70세 미만) **구제 항암 뒤 고용량 항암 + 자가조혈모세포이식**이 오래 쓰여 온 경로입니다. 이식이 어렵다면 구제 항암만 하거나 다른 선택지를 상의합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — R-CHOP 1주기 21일 달력, 스테로이드 관리

6장. 호지킨 림프종

30초 요약: 젊은 환자에게 많고 **완치율이 높은 편**입니다. 초기는 항암(± 방사선), 진행기는 **항암에 PD-1 면역치료를 더하는 요법** 또는 **CD30 표적 ADC를 포함한 요법**이 1차 범주입니다(최신 근거·국내 허가·급여 확인 필요).

- 면역치료 병용 시 갑상선 기능 변화, 숨참·기침, 심한 설사 같은 면역 관련 부작용을 알려 주세요.
- 요법에 따라 폐 독성·신경 독성·생식 독성이 달라 **가임력 상담**과 함께 상의합니다.

7장. 저등급(천천히 자라는) 림프종과 관찰

30초 요약: 증상이 없고 종양 부담이 낮으면 **관찰(watch and wait)**이 표준 선택입니다. 이 단계에서 일찍 치료해도 생존이 늘지 않는다는 연구가 관찰 전략의 근거입니다. 범위가 좁은 초기(I~II기)는 **방사선만으로** 오래 조절하거나 완치를 목표로 하기도 합니다.

- 관찰 중에는 보통 3~6개월마다 진찰·혈액검사를 하고, 영상은 증상이나 변화가 있을 때 주로 합니다(병원 방침 확인).
- 관찰 기간에 불안이 커지는 것은 자연스럽습니다. 관찰은 손을 놓는 것이 아니라, **정기 검사로 몸을 살피다가 꼭 필요할 때 치료를 시작하는 방식**입니다.
- 위 MALT 림프종은 **헬리코박터 제균**에 반응하는 경우가 많고, 반응하지 않으면 방사선을 씁니다.
- 여포성 림프종에서 치료가 필요해지면 항CD20 항체(리툰시맙 등)에 벤다무스틴이나 CHOP을 더한 요법을 흔히 쓰고, 반응한 뒤 항CD20 항체만 2년 가까이 이어 가는 **유지요법**을 하기도 합니다(국내 급여 기준 확인 필요). 국내 자료에는 '소포성 림프종'이라고도 적힙니다.

관찰 중 연락 신호

- ☐ 림프절이 빠르게 커짐 ☐ B증상(발열·식은땀·체중 감소) ☐ 심한 피로·빈혈 ☐ 장기 압박 증상 ☐ 새 통증

■ **완전판에서 이어집니다** — 관찰 일지와 가족에게 설명하는 말

8장. 방사선과 세포치료

30초 요약

- 방사선은 ① 초기 저등급 림프종의 근치 ② 항암 후 공고(남은 덩이·큰 덩이) ③ 증상 완화에 씁니다. 요즘은 **병이 있던 부위만 좁게** 조사합니다.
- **CAR-T**: 치료 후 일정 기간 치료기관 근처에 머물고, **보호자 24시간 동반**, 운전 제한(기간은 치료기관 안내)을 안내받습니다.

림프종의 3·4기는 고형암의 "전이"와 다릅니다. 공격성 B세포 림프종과 호지킨 림프종은 진행기에도 **완치를 목표로 치료하는 경우가 많고**, 저등급 림프종은 오래 조절하며 지내는 것이 목표일 수 있습니다. 아래 내용은 재발했거나 치료가 어려운 경우를 위한 것입니다.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것으로** 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법

PART 3. 30일 실행 로드맵

■ **완전판에서 이어집니다** — 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

감염 예방과 일상

30초 요약: 백혈구가 떨어지는 시기에는 **손 씻기, 사람 많은 곳 줄이기, 발열 시 즉시 연락**이 가장 중요합니다. 예방접종(생백신 제외)은 시기를 담당의와 상의합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 감염 예방 생활 수칙, 학업·직장 복귀

추적

- 치료 종료 후 PET/CT로 반응을 확인하고, 이후에는 진찰·혈액검사 중심으로 추적합니다. 증상이 없을 때 잦은 CT는 대개 필요하지 않습니다.
- 장기적으로 심장·갑상선(목 방사선)·이차암 검진을 상의합니다.
- 치료 뒤 엉덩이·무릎 관절이 계속 아프면 알려세요. 드물게 스테로이드 등과 관련된 뼈 괴사(무혈성 괴사)가 생길 수 있습니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 정확한 아형은요? 2. 병기와 B증상·큰 덩이 여부는요? 3. 바로 치료인가요, 관찰인가요? 4. 치료 요법과 주기는요? 5. B형간염 검사 결과와 예방약은요? 6. 가임력 보존 시간이 있나요? 7. 중간 PET은 언제 하나요? 8. 방사선이 필요한가요? 9. 바로 연락해야 할 증상은요? 10. 재발하면 CAR-T·이중특이항체 같은 선택지가 있나요?

내 림프종 한 장 요약

항목	내 기록
아형	_____
병기	_____ (B증상 ☐ / 큰 덩이 ☐)
LDH	_____
B형간염	HBsAg _ / <i>anti-HBc</i> _ · 예방약 _____
첫 치료	항암(요법 _____) / 관찰 / 방사선 / 제균
주기	_ 주기 중 _
가임력	해당 없음 / 상담 / 완료
산정특례	☐ 신청 ☐ 완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 제 아형은? ② 치료인가요, 관찰인가요? ③ B형간염 예방약이 필요한가요?

완전판에서 이어집니다

- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 림프종 용어사전
- 림프종 자주 묻는 질문 12
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — B-Cell Lymphomas / Hodgkin Lymphoma / T-Cell Lymphomas, Version 4.2026(B세포 림프종 기준). NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 림프종 정보, 대한혈액학회 림프종연구회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **출처:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터 — 사실 확인에 참고한 자료(센터 문장·그림은 실지 않음). 더 자세한 암 정보와 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899(평일 9~18시).

- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

완전판에는 이런 내용이 더 있습니다

- PET 판독지 읽기, 병리 체크표
- R-CHOP 1주기 21일 달력, 스테로이드 관리
- 관찰 일지와 가족에게 설명하는 말
- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법
- 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)
- 감염 예방 생활 수칙, 학업·직장 복귀
- 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)
- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것
- 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트

- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
 - 림프종 용어사전
 - 림프종 자주 묻는 질문 12
 - 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
 - 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력
-

ApuDa.app — 더 많은 암·질환 교육 콘텐츠와 업데이트 Instagram 구독자 무료 배포판 · 상업적 재배포 금지

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>